



Diagnostic différentiel d'une leucocorie



fibres medullaires



rétinoblastome



Colobome du nerf optique,
rétine est choroïde



Cataracte



maladie de Coats



rétinopathie
prématurée

P	348802	
Session	Quichutaf	Catalogue
Question type	Options	
Single Choice	1	5

Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)



DMLA sèche : drusen et altération de l'épithélium pigmentaire OG > OD

Première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés.

Prévalence : 1% à 55 ans, 25% à 75 ans

Forme sèche 85% au fond d'oeil : drusen, hypo, hyperpigmentation, atrophie de l'épithélium pigmentaire.

forme exsudative 15% : apparition de *néovaisseaux choroïdiens*, *œdème intrarétinien*, des *hémorragies* et un *décollement maculaire exsudatif*,

But thérapeutique:

1. diminuer la progression de la DMLA sèche (supplément de vitamines).
2. de supprimer les néovaisseaux dans la forme exsudative.

P 727511

Session : Quickstart

Question type:

Single Choice

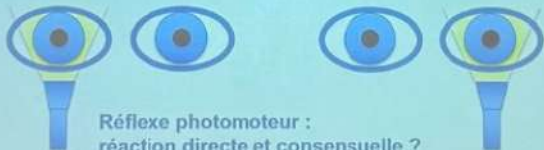
Examen des Pupilles

1



Anisocorie?

2



Réflexe photomoteur :
réaction directe et consensuelle ?

3



Miosis en convergence ?

Nerf optique normal



Oedème papillaire



Excavation
glaucomateuse



Atrophie du nerf optique



nerf optique
bord
vitalité
excavation

P 72711

Session	Quickstart	Création
Question type	Options	
Single Choice	N	





hypopyon



hyposphagme



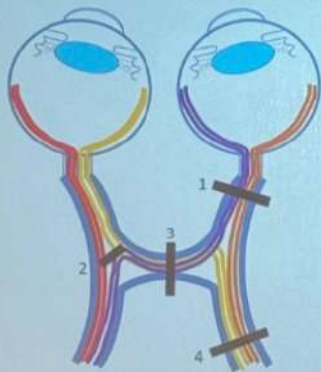
hyphéma

P 348502

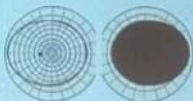
Session Quick

Question type:

Single Choice

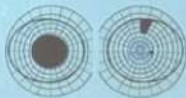


1



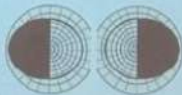
**Amaurose par lésion
complète du nerf optique**

2



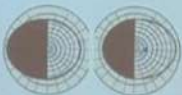
**Déficit du champs visuel
(scotome) jonctionnel par
lésion du nerf optique au
niveau de la jonction avec le
chiasme**

3



**hémianopsie bitemporale
par lésion des fibres
rétiniennes croisant**

4



**Hémianopsie homonyme à
gauche par lésion
rétrochiasmatique complète
des voies visuelles**

Œdème maculaire dans le cadre d'une rétinopathie diabétique non proliférante



P 727611

Session : Quidinet Ca

Question type : Opti

Single Choice 5

Le nerf optique dans une névrite du nerf optique



Nerf optique normal
(60%)

'Le patient ne voit rien et
le médecin ne voit
également rien'



oedème papillaire 30%



atrophie du nerf optique

Ce qu'on doit savoir sur l'OACR:

Mesures diagnostiques :

ophtalmo: VS, CRP Thrombocytes

neurologue: but principal et d'exclure une source d'embolus

Doppler

DWI-MRT, angio CT

ECG

TEE

RR – Monitoring

Si pas de source d'embolus:

Ac antiphospholipid, thrombocytose, déficience en facteur V Leiden,
déficience en protéine C S , antithrombine mutation génétiques de la
prothrombine, homocystéinémie)
maladies rhumatologiques

Occlusion de l'artère centrale rétinienne (OACR)

Incidence 1-2 in 100,000;
 10 in 100,000 chez les > de 80 ans

Cause la plus fréquente : embolie d'une source lointaine (le plus fréquent de l'artère carotidienne)

Facteurs de risque identiques avec ceux d'AVC

Hypertension artérielle	72%
Sténose de l'artère carotidienne:	40% sténose >70%
Maladie de coronaires	22%
Fibrillations ventriculaires	20%
Atteinte des valves cardiaques	17%

Dans 78% découverte d'un nouveau facteur de risque
(hypercholestérolémie, sténose de l'artère carotidienne)

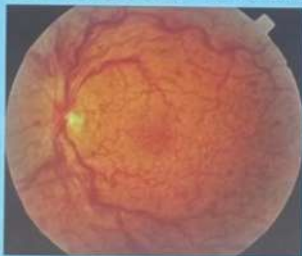
P 722011

Session: Quickstart

Question type:

Single Choice

Occlusion de la veine centrale (OVC)



Définition : Occlusion de la veine centrale rétinienne.

Facteurs de risque :

Chez personnes > 50 ans hypertension artérielle, glaucome, hyperlipidémie.

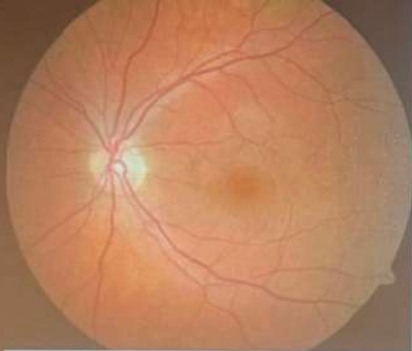
Chez personnes < 50 ans hypercoagulabilité sanguine/risque thromboembolique.

Symptômes : asymptomatique ou *baisse de vision* non douloureuse, parfois progressive

Fond d'œil : *Hémorragies intrarétiniennes* dans tous les quadrants, *tortuosité de veines*, parfois oedème papillaire, parfois exsudats durs (lipidiques) et mous (cottonneux = région ischémique rétinienne).

Risques principaux : 1. 30% des patients avec OVC ont des zones *ischémiques* dont la moitié développement des *néovaisseaux* (avec toutes les conséquences) 2. *Oedème n*

Traitement : si zones ischémiques : anti-VEGF ou cortisone intravitréen.



Le fond de l'oeil ci-dessus montre:

- A. une atrophie du nerf optique
- B. un nerf optique glaucomateux
- C. un oedème rétinien après occlusion de l'artère centrale
- D. un fond de l'oeil dans la norme
- E. une rétinopathie hypertensive

Un jeune patient de 22 ans se plaint depuis 8 semaines de céphalées présentes dès le matin, de vertiges, d'acouphènes, de sensations de fatigue et de dyspnée sur effort sportif moyen. Il a également eu plusieurs épisodes d'épistaxis et se plaint d'une vision floue des deux côtés. Le fond d'œil montre :

- A. une occlusion de la veine centrale rétinienne
- B. une rétinopathie diabétique
- C. une rétinopathie hypertensive
- D. une uvéite postérieure
- E. un œdème papillaire de stase

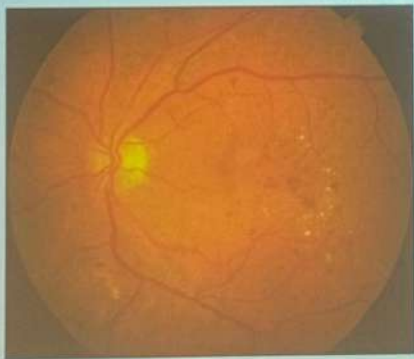


Au fond d'oeil, les premiers signes d'une hypertension artérielle moyenne sont:

Q3

- A. Des hémorragies superficielles en flammèche
- B. Des petits foyers blancs d'ischémie rétinienne (nodules cotonneux)
- C. Un rétrécissement artériel
- D. Un œdème du disque optique
- E. Des exsudats lipidiques

Vous examinez le fond d'oeil d'une femme de 48 ans connue pour une hypertension artérielle bien contrôlée depuis 10 ans. Le fond d'oeil est typique pour:



- A. une occlusion de la veine centrale rétinienne
- B. une rétinopathie hypertensive
- C. une rétinopathie diabétique
- D. une rétinopathie suite à des manœuvres de Valsalva répétées
- E. un fond d'oeil dans les limites de la norme



L'aspect de ce nerf optique est superposable avec

- A. un oedème papillaire
- B. une atrophie du nerf optique
- C. un nerf optique dans les limites de la norme
- D. une rétinopathie diabétique proliférative
- E. un nerf optique glaucomateux

Un diabète de longue durée peut entraîner comme complication oculaire tous les diagnostics ci-dessous **sauf** :

- A. une cataracte
- B. un décollement de rétine
- C. une maculopathie
- D. un glaucome néovasculaire
- E. une uveite antérieure

La présence d'une rétinopathie diabétique non proliférante peut être typiquement associée à

- A. une baisse de vision importante
- B. une inflammation de la chambre antérieure
- C. un risque d'amblyopie
- D. une myopisation
- E. une élévation de la pression intraoculaire



Quel symptôme n'est pas typique pour la condition visible sur la photo?

- A. Perception d'étincelles (photopsies)
- B. Perception d'une ombre
- C. Sentiment de douleur
- D. Baisse d'acuité visuelle
- E. Perte du champ visuel

Vous êtes généraliste. Une de vos patientes vous annonce qu'elle est enceinte. Un bilan sanguin vous fait suspecter un **diabète gestationnel**. Il est indiqué de :

- A. Référer la patiente immédiatement à un ophtalmologue pour faire un screening de rétinopathie diabétique.
- B. Référer la patiente à un ophtalmologue le 1^{ère} trimestre.
- C. Référer la patiente à un ophtalmologue le 2^{ème} trimestre.
- D. Référer la patiente à un ophtalmologue le 3^{ème} trimestre.
- E. De ne pas référer la patiente à un ophtalmologue si la patiente ne souffre pas de symptôme.

Chez un enfant avec manifestation d'un diabète type I il est recommandé pour un screening de rétinopathie diabétique:

- A. d'adresser l'enfant à l'ophtalmologue 5 ans après le diagnostic.
- B. d'adresser l'enfant à l'ophtalmologue dans l'année qui suit la pose du diagnostic.
- C. d'adresser l'enfant à l'ophtalmologue seulement en cas de symptômes.
- D. d'adresser l'enfant à l'ophtalmologue car une rétinopathie diabétique est une grande exception avant l'âge de 30 ans.
- E. toutes les affirmations sont fausses.

Une femme de 75 ans se plaint d'une baisse de vision progressive depuis 2 années.

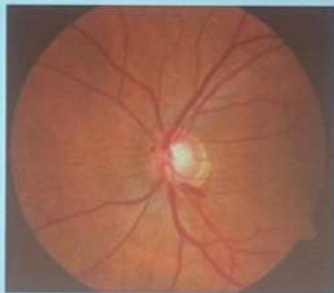
Son opticien lui a conseillé d'aller voir un ophtalmologue pour faire un bilan. Toutes les conditions listées ci-dessous peuvent être à l'origine de cette baisse de vision progressive **sauf**:

- A. une cataracte bilatérale
- B. un glaucome à angle ouvert
- C. une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)
- D. un méningiome avec atteinte des voies visuelles
- E. une névropathie optique ischémique antérieure (NOIA) bilatérale

Un homme de 45 ans se présente avec des difficultés à la lecture malgré de nouvelles lunettes adaptées par l'opticien.
Son fond d'oeil montre :



- A. une hypertension artérielle
- B. un oedème papillaire
- C. des papilles évoquant une sclérose en plaque
- D. des nerfs optiques dans les limites de la norme
- E. des papilles avec une excavation glaucomateuse

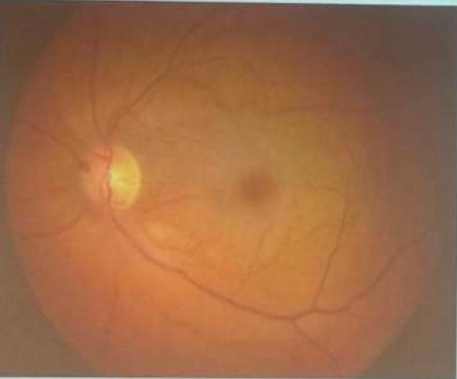


Les traitements suivants pourraient être indiqués chez ce patient sauf :

- A. β -bloquants topiques
- B. Analogues de prostaglandines topiques
- C. Inhibiteurs de déshydrogénase topique
- D. Inhibiteurs de carboanhydrase topiques
- E. Cortisone systémique

Un patient avec un glaucome chronique à angle ouvert prend des collyres depuis plusieurs années. Il se plaint qu'il a l'impression que ses yeux sont devenus plus foncés et que ses cils se sont agrandis. Se patient a comme traitement anti-glaucomeux des collyres

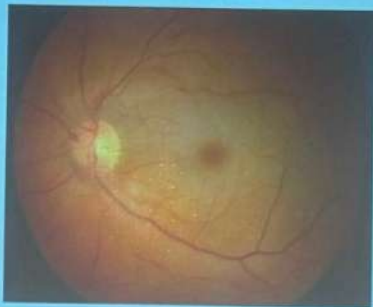
- A. de bêta-bloquants
- B. d'analogues de prostaglandines
- C. d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique
- D. de pilocarpine
- E. d'épinéphrine



Un patient de 65 ans présente une baisse de vision aiguë (perception lumineuse) sur l'oeil gauche depuis 24 heures. Il ne se plaint d'aucune douleur ou autre symptôme. Ci-contre, le fond de l'oeil de ce patient.

Il s'agit d'une :

- A. Névrite du nerf optique
- B. Ischémie du nerf optique
- C. Artérite du nerf optique
- D. Occlusion de la veine centrale
- E. Occlusion de l'artère centrale



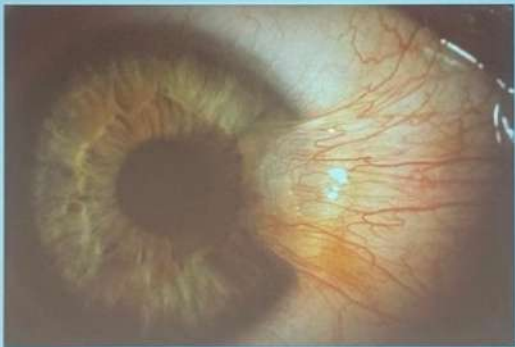
La première démarche chez ce patient est :

- A. d'initier une thrombololyse en urgence.
- B. de baisser la pression intra-oculaire en urgence.
- C. d'adresser le patient en urgence aux neurologues après avoir exclu une maladie de Horton.
- D. de donner de l'oxygène pure.
- E. d'exclure des facteurs de risques vasculaires par le médecin traitant.

Quelle est la différence clinique entre un oedème papillaire de stase (p.ex. dans le cadre d'une tumeur intracrânienne) et un oedème papillaire dans le cadre d'une névrite du nerf optique?

Q18

- A. L'oedème papillaire de stase est plus important que l'oedème papillaire d'une névrite du nerf optique.
- B. L'altération du champs visuel est plus important dans l'oedème papillaire de stase.
- C. Cliniquement, il n'est pas possible de faire une différence entre ces deux conditions.
- D. L'oedème papillaire de stase n'est typiquement pas accompagné d'une réduction de l'acuité visuelle.
- E. La névrite ne fait pas d'hémorragie péripapillaire.



Quelle proposition concernant la lésion ci-dessus est **fausse** ?

- A. La lésion peut induire un astigmatisme.
- B. Une exposition au soleil est un facteur de risque.
- C. Il y a un danger de transformation maligne de 1%.
- D. La lésion est souvent bilatérale.
- E. Le traitement conseillé serait une chirurgie.

Une femme de 45 ans se plaint d'une baisse de vision de l' OG depuis 4 semaines. Son acuité visuelle est de 0.3 sur son OG. Elle indique ne pas avoir de maladie systémique. Elle prend des contraceptifs oraux. Le fond d'oeil est typique pour :

Q20



- A. une occlusion de l'artère centrale rétinienne
- B. Une névrite du nerf optique
- C. Une ischémie du nerf optique
- D. Une rétinopathie après manoeuvre de Valsalva
- E. Une occlusion de la veine centrale

Une femme de 24 ans se présente avec une baisse de vision aigue sur un œil. Elle confirme un inconfort sur cet œil qui se majore en regardant d'un côté à l'autre et qui a précédé la baisse de vision de 2 jours. L'examen du segment antérieur et du fond de l'œil ne révèlent aucune anormalité. Quel est votre diagnostic suspecté?

- A. Maculopathie aigue
- B. Baisse de vision fonctionnelle
- C. Névrite du nerf optique
- D. Lésion ischémique du nerf optique
- E. Dégénérescence de la rétine

Les signes et symptômes cliniques suivants sont typiques pour une névrite du nerf optique unilatérale sauf :

- A. Un trouble de la vision stéréoscopique
- B. Déficit pupillaire afférent
- C. Un trouble de la vision de couleurs
- D. Une altération du champ visuel
- E. Une anisocorie

L'expression „ le patient ne voit rien et le docteur ne voit rien non plus“ s'applique à des patients avec une baisse de vision dans le cadre d'une :

- A. Névrite du nerf optique
- B. Ischémie du nerf optique
- C. Artérite du nerf optique
- D. Occlusion de la veinne centrale
- E. Occlusion de l'artère centrale

Une femme de 38 ans se plaint de **maux de tête progressifs** depuis quelque mois et d'une **altération de la vision**. Son médecin traitant lui prescrit une IRM cérébrale dont vous voyez le résultat ci-dessous.

Q 24

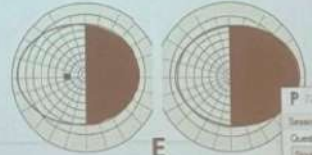
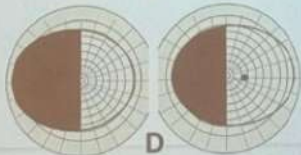
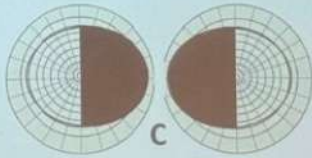
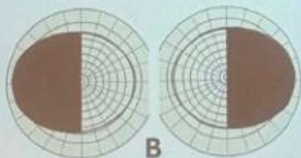
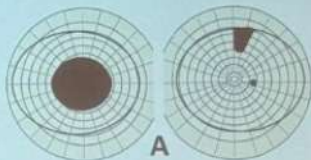


Le diagnostic le plus probable est :

- A. un kyste dermoïde
- B. un macroadénome hypophysaire
- C. un prolactinome
- D. un germinome
- E. aucune réponse est vraie

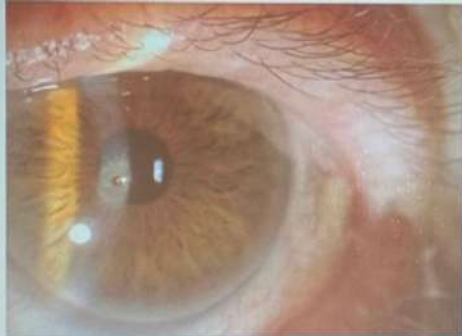
Chez cette patiente le champs visuel correspondant à sa lésion est

Q 25



P 22/01/11

Session: QuizStart Catalog
Question type: Options
Single Choice 3



Monsieur vient aux urgences pour un œil gauche rouge et douloureux depuis hier.

Quel est le diagnostic :

- A. Conjonctivite
- B. Épisclérite
- C. Uvéite
- D. Corps étranger cornéen
- E. Kératite



La mesure la plus appropriée pour ce patient est :

- A. de réaliser un scanner cérébral
- B. de réaliser une IRM
- C. de donner des antibiotiques systémiques
- D. de faire une ablation du corps étranger à la lampe à fente
- E. de demander un avis chirurgical

Quelle maladie / chirurgie n'est pas associée à un risque d'endophthalmie ?

- A. Septicémie
- B. Chirurgie de cataracte
- C. Trauma pénétrant
- D. Contusion du globe
- E. Chirurgie du glaucome

Vous examinez un patient de 82 ans avec des céphalées pesantes et une douleur au niveau de l'artère temporale. Le patient a subi plusieurs épisodes d'amauroses fugaces. La formule sanguine montre une anémie hypochrome. La VS est à > 100 après une heure, la CRP est à 42. Quelle est votre attitude ?

- A. Organiser IRM en urgence puis adresser le patient aux neurologues.
- B. Traitement des maux de tête et commencer une antibiothérapie par voie i.v., pour traiter une vasculite géantocellulaire.
- C. Traiter avec un bolus de stéroïdes par voie i.v., ensuite référer le patient pour une biopsie de l'artère temporale.
- D. Traitement avec stéroïdes seulement si la biopsie de l'artère temporale est positive pour une vasculite géantocellulaire.
- E. Faire une hémodilution et traiter les maux de tête avec paracétamol.



Un patient a spontanément développé la rougeur au niveau de l'oeil documenté sur la photo ci-contre. Quelle affirmation n'est pas correcte?

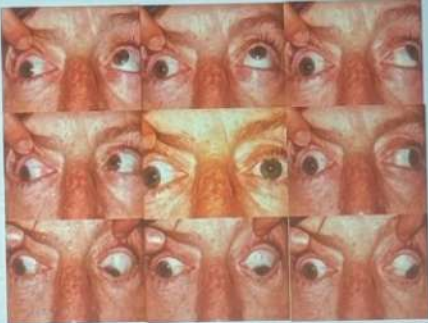
- A. La condition peut se manifester spontanément.
- B. Une hypertension artérielle peut être à son origine.
- C. Une baisse de vision n'est pas associée.
- D. Cette condition est douloureuse.
- E. Les lésions visibles peuvent se manifester après un traumatisme mineur.



Un homme de 24 ans se présente avec une baisse de vision. La cornée montre la lésion documentée sur la photo.

Quelle affirmation est correcte ?

- A. Il s'agit d'une infection bactérienne.
- B. La lésion se traite avec des antibiotiques systémiques.
- C. La lésion est provoquée par une infection virale.
- D. Il s'agit d'une lésion d'un sapin de Noël.
- E. Il s'agit d'une lésion traumatique.



Une patiente présente depuis 2 jours un ptosis associé à des céphalées importantes. La position oculaire et la motilité sont montrées sur la photo. Quelle affirmation est correcte?

- A. Il faut faire une correction prismatique.
- B. Une intervention chirurgicale en urgence est recommandée pour préserver la vision binoculaire.
- C. **Une IRM en urgence est indiquée.**
- D. Un Scanner cérébral est indiqué.
- E. Il s'agit d'une parésie du Nerf IV.

Patiente de 24 ans se plaint de diplopie suite à un traumatisme crânien par AVP. Quelle affirmation est correcte ?



Regard à droite



Regard tout droit



Regard à gauche

- A. Il s'agit d'une parésie du N.VI de l'oeil gauche.
- B. La patiente doit être opérée dans les 3 mois qui suivent l'
- C. La patiente souffre d'une diplopie croisée.
- D. Un traitement avec des prismes est le traitement de 1^{er} ch
- E. Aucune de ces affirmations n'est correcte.

P 348502

Session Quickstart Cera

Question type Option

Single Choice 5

Les photos montrent la position oculaire chez une patiente qui se plaint de diplopie depuis 3 ans.
Quelle affirmation est correcte ?



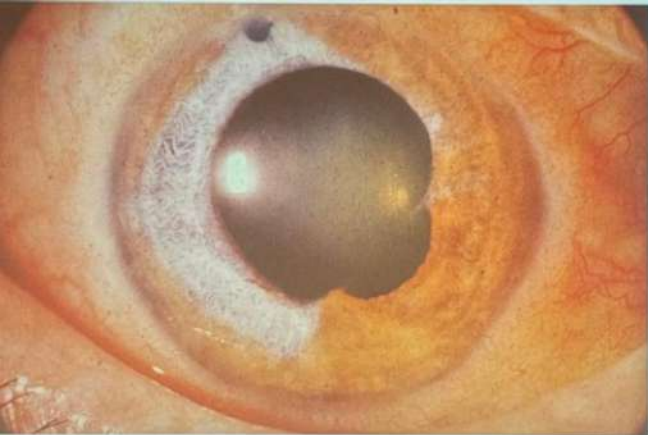
- A. Il s'agit d'une parésie du N.IV de l'oeil droit.
- B. La photo montre le test d'Amsler.
- C. La patiente souffre d'une faiblesse de son oblique sup. ga.
- D. Un traitement avec des prismes est le traitement de 1^{er} ch.
- E. Aucune de ces affirmations n'est correcte.

P 348502

Session: Quicktest Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 1/5



- A. Appeler un chirurgien
- B. Faire une IRM abdominale en urgence
- C. Angiographie de l'oeil en urgence
- D. Doppler des artères carotidiennes en urgence
- E. Palpation du globe

Un patient de 68 ans se plaint d'une baisse de vision aiguë, douloureuse et unilatérale accompagnée de nausées, vomissements et crampes abdominales. Il dit voir comme à travers un brouillard. Il voit des 'anneaux colorés' autour des sources lumineuses.

Vous examinez le patient et vous constatez un oeil rouge avec une pupille en semi-mydriase, qui ne réagit pas à la lumière.

Quelle mesure prenez-vous pour confirmer votre diagnostic suspecté avant de le référer à un ophtalmologue?

La condition visible sur la photo ci-dessous est appelée:



- A. un hyposphagme
- B. un hyphéma
- C. un hypopyon
- D. une leucocorie
- E. une papilla leporina

Une femme de 45 ans se plaint d'une douleur oculaire importante parvenue subitement avec larmoiements, photophobie et baisse de vision. La photo de son oeil atteint montre :



- A. un hyposhagme
- B. une conjonctivite
- C. une sclérite antérieure
- D. une uvéite
- E. une infection herpétique

P 348302

Session: Quickstart Catalogue

P

Question type: Options

Single Choice 5

Quelle affirmation est correcte concernant la sclérite?

- A. Une sclérite est souvent très douloureuse. Les douleurs peuvent irradier aux alentours de l'oeil.
- B. Une sclérite est souvent associée à des maladies systémiques
- C. La maladie la plus fréquente associée à une sclérite est l'arthrite rhumatoïde.
- D. Une sclérite peut aboutir à des séquelles visuelles irréversibles
- E. Toutes les affirmations sont correctes.

Réflexe photomoteur dans une atteinte du nerf optique de l'oeil droit (OD)

(Déficit afferent relatif pupillaire (anglais: **Relative Afferent Pupillary Deficit** = **RAPD**))



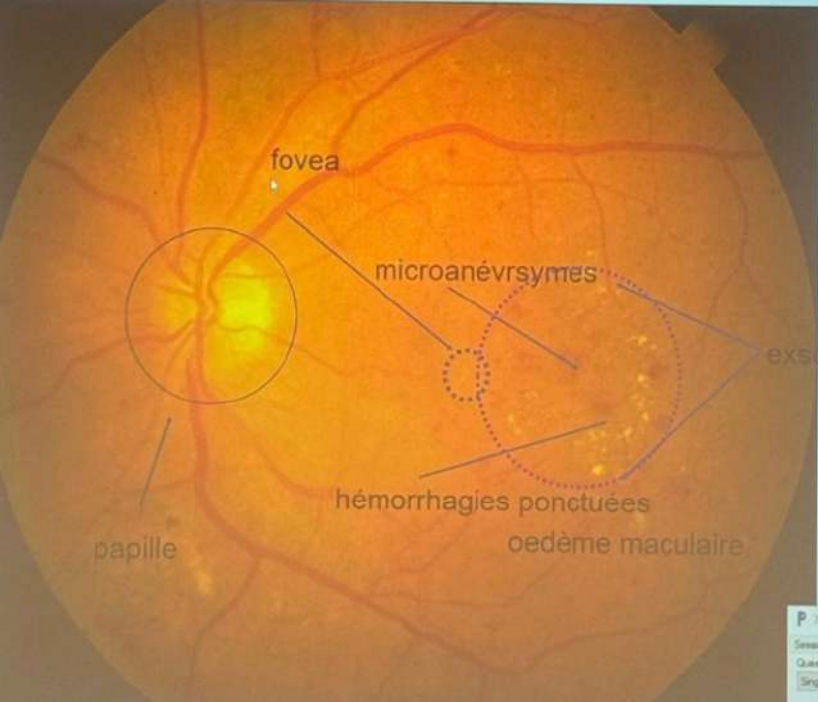
Isocorie!



La réaction pupillaire directe du **côté atteint** (et la réaction consensuelle du côté non-atteint) sont **réduites**.



La réaction pupillaire directe du **côté non-atteint** (et la réaction consensuelle du côté atteint) ne sont **pas réduites**.



P 727511

Session: Quidklat Catalogue

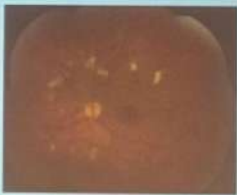
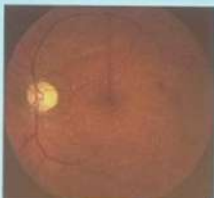
Question type: Options:

Single Choice 5

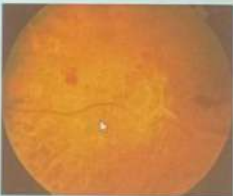
Rétinopathie diabétique

rétinopathie diabétique
non proliférante

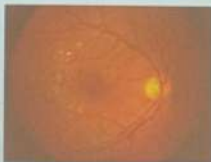
(hémorragies,
microanévrismes, IRMA,
nodules cottoneux, exsudats
lipidiques,



rétinopathie diabétique
proliférante
(néovaisseaux)



Maculopathie diabétique
ischémique/ oedémateuse



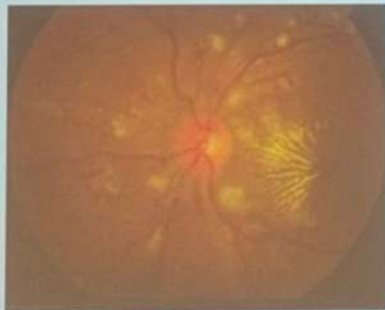
stade	Signes au fond d'oeil
I	Rétrécissement artériolaire généralisé, sclérose artériolaire minime
II	Rétrécissement artériolaire focal et signes du croisement artério-veineux ; sclérose artériolaire modérée à sévère
III	Signes de rétinopathie hypertensive de stade 2 avec hémorragies rétiniennes, exsudats durs et / ou mous
IV	Signes de rétinopathie hypertensive de stade 3 avec oedème papillaire

Rétinopathie hypertensive artérielle



Stade II

Stade III



Stade IV

